

Dietary cholesterol and egg yolks: Not for patients at risk of vascular disease

A widespread misconception has been developing among the Canadian public and among physicians. It is increasingly believed that consumption of dietary cholesterol and egg yolks is harmless. There are good reasons for long-standing recommendations that dietary cholesterol should be limited to less than 200 mg/day; a single large egg yolk contains approximately 275 mg of cholesterol (more than a day's worth of cholesterol). Although some studies showed no harm from consumption of eggs in healthy people, this outcome may have been due to lack of power to detect clinically relevant increases in a low-risk population. Moreover, the same studies showed that among participants who became diabetic during observation, consumption of one egg a day doubled their risk compared with less than one egg a week. Diet is not just about fasting cholesterol; it is mainly about the postprandial effects of cholesterol, saturated fats, oxidative stress and inflammation. A misplaced focus on fasting lipids obscures three key issues. Dietary cholesterol increases the susceptibility of low-density lipoprotein to oxidation, increases postprandial lipemia and potentiates the adverse effects of dietary saturated fat. Dietary cholesterol, including egg yolks, is harmful to the arteries. Patients at risk of cardiovascular disease should limit their intake of cholesterol. Stopping the consumption of egg yolks after a stroke or myocardial infarction would be like quitting smoking after a diagnosis of lung cancer: a necessary action, but late. The evidence presented in the current review suggests that the widespread perception among the public and health care professionals that dietary cholesterol is benign is misplaced, and that improved education is needed to correct this misconception.

Résumé Une idée fausse et généralisée se répand au sein du public canadien et des médecins, qui pensent de plus en plus que la consommation de cholestérol alimentaire et de jaunes d'œuf est inoffensive. Les recommandations de longue date qui préconisent de limiter le cholestérol alimentaire à moins de 200 mg/jour reposent sur de bonnes raisons. Un seul gros jaune d'œuf contient environ 275 mg de cholestérol (plus que la portion quotidienne de cholestérol). Même si certaines études ont démontré que la consommation d'œufs n'est pas nuisible chez les personnes en santé, ce résultat peut découler de l'absence de capacité à déceler des augmentations

pertinentes sur le plan clinique au sein d'une population à faible risque. De plus, les mêmes études ont révélé que chez les participants devenus diabétiques pendant la période d'observation, la consommation d'un œuf par jour doublait leur risque par rapport à la consommation de moins d'un œuf par semaine. Le régime ne vise pas à éviter le cholestérol, mais surtout les effets postprandiaux du cholestérol, des gras saturés, du stress oxydant et de l'inflammation. Le fait de se concentrer à tort sur les lipides à jeun occulte trois enjeux. Le cholestérol alimentaire accroît la susceptibilité des lipoprotéines à faible densité à l'oxydation, accroît la lipémie postprandiale et potentialise les effets secondaires des graisses saturées alimentaires. Le cholestérol alimentaire, y compris les jaunes d'œuf, est nuisible pour les artères. Les patients vulnérables aux maladies cardiovasculaires devraient limiter leur consommation de cholestérol. Le fait d'arrêter de consommer des jaunes d'œuf après un accident vasculaire cérébral ou un infarctus du myocarde s'apparenterait à arrêter de fumer après un diagnostic de cancer du poumon : c'est un geste nécessaire, mais entrepris tardivement. D'après les données probantes présentées dans la présente analyse, la perception généralisée du public et des professionnels de la santé selon laquelle le cholestérol alimentaire est un mal bénin est une idée fausse, et une meilleure information s'impose pour la corriger.